



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نادية جمعه على بدوى
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : البدرشين
رقم البطاقة : 27302032100986 رقم التليفون : 01099571502
العنوان : قرية دهشور
العمر (تاريخ الميلاد) : 03-02-1973 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغة [11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ناديه جمعه على بدوي National ID: 27302032100986	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تعريف شخصية



ناديه
جمعه على بدوى
قرية دهشور
مركز البدرشين - الجيزة

١٩٧٣/٠٧/٢٢ ٢٧٣.٠٢.٣٢١.٠٠٩٨٦

LM2374360

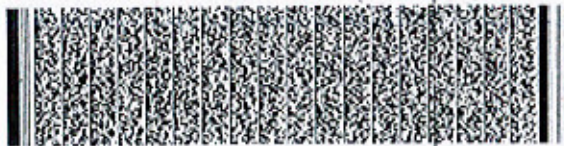
٢٠٢٥/١١ ٢٧٣.٢.٣٢١.٠٠٩٨٦

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
مصطفى سيد عبد الحميد نازل

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/١١/١٩







رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2025-11-17

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانبثاق الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي

والبحث تبين أن

السيد (ة) نادية جمعه على بطاقة رقم 27302032100986
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة لتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2025-11-17



قاعدة مركز نظم المعلومات
يعتمد...



مسلسل 1829147



الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

Name: <u>ناديه جمعه علي محمد</u>		
MR. : <u>8177</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:	رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
تاريخ وساعة الدخول :	تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
Diagnosed since November 2025 , Delayed course of action d t metastatic work up delay _ mass is 3*3 cm with average breast size (T2 N1 M0) ER 5/8, PR 0/8, HER2 +VE FOR TCHP FOLLOWED BY MASTECTOMY C1 TCHP Q 21 DAYS EF 66% 14/4 LABS PENDING pt admitted to icu due to af +hypertensive and pneumonia to shift to taxwol /carbo weekly today :c2w1 tc c2w2+c2w3 in ph(CARBO 1.5) Pharmacy Note Wt: 60, Ht:160, BSA: 1.6, AdBwt: 55.4 Pharmacy Note Hypersensetivity reaction with carboplatin. Hydrocortisone + Chloropheniramine was added, upon which patient stabilized but refused to continue Pharmacy Visit Wt: 60, Ht: 160, BSA: 1.6, AdBwt: 55.4 For C2 W3 Taxol 120 + Carboplatin AUC 1.5 Over 2 hours Labs 2/6 ... accepted postm rt breast cancer ct2 n1 mo idc 2 er5/8 pr0/8 her23+ af on cardiac tt ef 66% cts rt iliac sclerotic bone lersio for bs bs free for c4 w1 taxol 108 (10% dr) and carbopl auc 1.5 c1 loading phesgo bec of grade 2 diarrhea ps 3 on exam rt breast mass 2x2 for c4 w2 taxol , carbo 1.5 c4 W3 tc >> pharmacy approval of phesigo still pending clinical pharmacy note : c4w3 taxol 108 carbo auc 1.5 for c1 loading phesgo, echo will be done today (theres an old echo, also accepted) + c5w1 tc, labs accepted new echo 58% ef, give cycle and follow up echo every 2 cycles c5w2 and 3 pharmacy pt had developped empyema and onserted pigtail 10 days ago cytology suppurative no malignancy for c2 phesgo and postpone chemo no approval of phesgo yet pt did not receive phesgo yet		
تحريراً في ,		
التاريخ :	19-09-2026	الوقت :
الطبيب المعالج :	هنا أسامه عبد الرحيم عبد البر	
يعتمد ,		

Patient Name :
 Patient No : 27302032100986
 Path No : 3645/25
 Sex : Female
 Age : 52 Y
 Referring Doc :

Request No : 12003591
 Request Date : 24/11/2025
 Verification Date : 03/12/2025
 Financial Category :
 Department :
 Registered by :
 Out Patient :
 : marya mohamed

Pathology Report

Clinical Data
Right breast mass BIRADS 4c

Nature of specimen
Tru cut biopsy collected 24/11/2025, at 10:30 am

Gross examination
Five grey white tissue cores ranging from 0.5 cm up to 1 cm, totally submitted
Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against HER2/NEU (4B5), Ki67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

- Microscopic examination
- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
 - * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+3+2) Grade 3
 - * DCIS: Focal, Intermediate grade and high grade (solid and cribriform patterns)
 - * Lobular Intra epithelial neoplasia : Absent
 - * Angiolymphovascular invasion: Absent
 - * Microcalcification : Absent
 - * Perineural invasion: Absent
 - * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - * ER: Weak nuclear reaction in 60% tumor cells (Allred score 5/8)
 - * PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
 - * HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (3+)
 - * Ki 67: 45 %

Verified by :

Request No. 10000591
Request Date 24/11/2024
Verification Date 03/12/2025
Financial Category 03/12/2025
Department Out Patient
Registered by marwa mohamed youssef
port

Pathology Report

Diagnosis

RIGHT BREAST MASS. Tru cut biopsy
- Invasive duct carcinoma Grade 2
(according to Nottingham)

RIGHT BREAST MASS. Tru cut biopsy:
 - Invasive duct carcinoma Grade 3 (tubular differentiation 3, pleomorphism 3, mitoses 2).
 (according to Nottingham grading system of breast cancer), with focal intermediate grade
 and high grade duct carcinoma in situ (solid & cribriform pattern).
 IPI:
 * ER: Positive (score 5/8).
 * PR: Negative (score 0/8).
 * HER2: Positive (score 3+).
 K67: Positive (score 3+).

ER: Positive (score 5/8)
PR: Negative

PR: Negative (score 0/8)
HER2: Positive

HER2: Positive (score +3)
Ki67: 45 %

KI67: 45 %

Scoring system: ER, PR

staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO

scoring system. "Her2" score: proportion of cells between 67%-100% of the cells (staining). Intensity of positive staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete and/or weak/moderate and circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature

Salaa Ibrahim Ghonelm

Verified by :

Patient ID: 90085	Patient Name English: Nadiyah Gumaah A.E. Badawi
Age: ٥٢ سنة ٩ شهر	2025/11/13 11:29:42 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 50 years old, right breast lump of 15 days duration:

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ middle third irregular speculated dense mass lesion with extensions towards the nipple associated with few scattered foci of macro& microcalcifications .
- Ultrasound demonstrated a corresponding irregular hypoechoic solid mass with speculated margin and posterior shadowing, seen extending from 9:00 outer zone about 6cm from the nipple till 12 o'clock position with intraductal extension & ductal dilatation around 9 mm at 5.3 – 5.5 mm from the overlying skin,
- it measures around 5.3 x 4.6 x 3 cm with high vascularity on color Doppler interrogation .
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Multiple pathological axillary LNs (about 3) seen at level I some show showing thickened cortex reaching 4 mm & eccentric hilum , others show lost fatty hilum .
- No supra or infraclavicular LNs .
- Left breast
 - Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
 - No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
 - Ultrasound confirmed no suspicious masses or cystic lesions
 - Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
 - Mild prominent ducts with clear content .
 - Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 4c) An UOQ ?/ multifocal suspicious solid mass lesion with intraductal extension as above described as well as ipsilateral pathological level I axillary lymph nodes for tissue biopsy and histopathological verification .
- CESM is recommended for better staging .



TAHIRA
RADIOLOGY
CENTER

مركز تاهير للتصوير الطبي
مركز تاهير للتصوير الطبي
مركز تاهير للتصوير الطبي

مركز تاهير للتصوير الطبي
مركز تاهير للتصوير الطبي

مركز تاهير للتصوير الطبي
مركز تاهير للتصوير الطبي

Name: Mrs. Nadia Goman Ali Badawy

Acc.: 5222305

ID: 2226004342

Date: 5/2/2026

Referring Prof. Dr. Jostaf Rosi

Tc 99m MDP whole body bone scan

Tc 99m MDP whole body bone scan

Technique:

- Whole body images were acquired at 180 minutes following IV injection of 20 mCi of the tracer.

Findings:

- Uniform tracer uptake all over the surveyed skeleton is noted with no evidence of any active spots.
- Degenerative changes of the spine are seen.
- Arthritic knee changes are noted.
- Both kidneys are visualized.

Opinion:

No scintigraphic evidence of metastatic osseous deposits.

Truly yours

Prof. Dr. Ahmed Kandeel, MD

Prof. of Nuclear Medicine, faculty of medicine, Cairo University

Typed: M. Ali 00107200 - 454 34 100

Code: F/TRC-OP-20-01

Page 1 of 1

Issue No. (1)

مركز تاهير للتصوير الطبي
مركز تاهير للتصوير الطبي



HOTLINE
19173



مركز تاهير للتصوير الطبي
مركز تاهير للتصوير الطبي

Name : Nadia Gomaa Ali Badawi

Date : 10-09-2026 02:11

Branch : Dokki

Medical No. : 458945

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

تعلق مستشفى : Ins.Company :

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

Clinical Indication: 53-year-old female with right breast carcinoma (unresected), currently on chemotherapy. Referred for staging/follow-up skeletal evaluation compared to prior study dated May 2, 2026.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views, following intravenous administration of 99mTc-MDP.

Findings:

- Homogeneous symmetric physiological tracer distribution throughout the axial and appendicular skeleton, including the skull, spine, ribs, sternum, pelvis, and extremities.
- No focal areas of abnormal increased uptake suggestive of osteoblastic metastases.
- Mild localized tracer concentration is noted in the lower lumbar spine and bilateral knee joints, consistent with degenerative changes; unchanged compared to the prior study.
- Renal excretion is prompt and symmetric. No abnormal soft tissue uptake.

Impression:

- No scintigraphic evidence of skeletal metastases.
- Stable compared to prior study (May 2, 2026).

Dr. Alaa Nagi

MD Nuclear Medicine

N I L E D I A G N O S T I C C E N T E R

Patient's Name:
Date:
Referred by:
Hospital:

Nadia Gomaa Ali Mohammed
2026-09-03
Prof.Dr. no doctor
Goustave Roussey International Egypt

**MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

I- CHEST:

- Right moderate pleural effusion with underlying lower lobar consolidation/collapse and associated fibrotic strands.
- Few scattered nodules the largest seen in the left lower lobe measuring 13 x 8.8 mm.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No left pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

I- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Enlarged spleen with subcapsular fluid density at its upper pole showed no enhancement.
- Normal C.T appearance of the pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ Right moderate pleural effusion with underlying lower lobar consolidation/collapse and associated fibrotic strands.
- ❖ Few scattered pulmonary nodules likely metastatic .
- ❖ Fatty hepatomegaly

Dr.Asser Ahmed

PATHOLOGY REPORT

Code:	29426507924 -(P 25876-26)			Patient Name:	ناديه جمعه على
Age:	54 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	10/08/2026
Branch:	Omrania			Date Report Issued:	12/08/2026
Referred By Prof:	-				Unit Consultant: Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of known right breast cancer with right sided pleural effusion, suspected chylothorax due to malignant invasion to lymphatics.

SPECIMEN: Pleural fluid for cytology.

GROSS PICTURE:

4 c.c. of turbid creamy brownish fluid.

MICROSCOPIC PICTURE:

Cytological examination revealed necrotic background entangling many PNLs, pus cells, macrophages, intact and hemolysed RBCs, cellular debris as well as few bland looking mesothelial cells.
No viable cytologically malignant cells was seen.

DIAGNOSIS: Pleural fluid for cytology:

- **Suppurative Smears for Clinical and Microbiological Correlation.**
- **International System for Reporting Serous Fluid Cytopathology, Negative for**

Malignancy.

* 1 enclosed slide.

Samar ELsheikh

Dr. Samar El Sheikh.
Professor Of Pathology
Faculty of Medicine, Cairo

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

جوليا روستاف
4 أكتوبر 2026

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

09/27/2026

MDT FORM

Name:	Nadia Gomaa Ali Mohamoud	MRN:	8177
Age:	54 Y	ID:	27302032100986
Menopausal Sta	perimenopausal	Phone:	01117829621
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	

Clinical Data:

R

BX: idc 2

ER: 5/8 PR: 0/8 HER2: +3 KI67: 45%

Sonomam mography:

Mets Workup:

History:

RT breast cancer started NACT received 5 cycles taxol/carbo weekly last 27/7/2026 Without phiesgo as was refused by MOH (requested new cts and bone scan)

at the beginning of 8/2026 developed empyema and inserted pigtail in the RT lung >> cytology -ve of malignancy

CT CAP 3/9 >> RT moderate pleural effusion + few scattered nodules the largest seen in the left lower lobe 13*8.8 mm

bone scan (10-9-2026) : free

ECOG 1

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

for pleural fluid cytology as per radiology request
TO CONTINUE TAXOL WEEKLY WITH HERCEPTIN TO BE EVALUATED AFTER 9 WEEKS

SIGNATURE

MEDICAL DNCOLGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. حنان عزت	د. احمد نجيب				

about:blank